

Información Paciente

Nombre : Camila Alexandra Baez Carcamo
Edad : 24a 6m 1d
Dirección : Nataniel Cox 135

Rut : 20.272.643-7
Fecha Nacto: 18/06/2000
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2425542
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 2392 9650

N° Epicrisis
424662

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 26/11/2024 13:27

Días Estadía: 23

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 19/12/2024 17:12

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

ictericia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI HSR: 26/11/24. 20 días hospitalización
FI I. Qx: 13/12/2024

ANTECEDENTES:

Mórbidos:

Atresia Vía Biliar rechazo Trasplante Hepático. Nuevo trasplante hepático. Rechazo crónico ductopénico. Colangitis a repetición
QX: CX KASAY 2 meses de vida; 2 TRANSPLANTES HEPÁTICOS (Hosp. Calvo Mackena) 12 y 15 años, Cesárea hace 2 años.

Fármacos: Tacrolimus, Rapamicina, Rifaximina, Omeprazol, Quetiapina, Escitalopram, Calcio, K, Ac. ursodeoxicólico

Hábitos: (-)

Alergias :(-)

Domicilio: Puerto Montt

HISTORIA:

Pcte con antecedentes descritos; último episodio de Colangitis hace 2 años, consulta por ictericia obstructiva.

Se hospitaliza para estudio El día 26/11/24 se realiza COLANGIOGRAFÍA: DRENAJE BILIAR INTERNO-EXTERNO + PLASTIA BILIAR.

Se realiza colangiografía, identificando fistula bilio arterial en ramas derechas. Se avanza guía hasta duodeno y se retira drenaje antiguo, con algo de sangrado, posiblemente en relación a fistula. Colangiografía a través de Vaina muestra vía biliar intrahepática derecha e izquierda comunicadas. A izquierda, vía biliar irregular, pudiese estar en contexto de secuelas de isquemia biliar. A derecho aspecto normal. Se realiza plastia y se instala drenaje biliar interno-externo 12Fr. Colangiografía final demuestra adecuado paso de contraste, sin evidencia de la fístula identificada inicialmente.

Posterior a procedimiento, queda hospitalizada en Cx sector B. Evoluciona febril, se toman HCs donde se aísla:

HC1 tardío Streptococo anginosus + HC2 14 hrs E Coli MS. Queda con tto ATB 1° línea, ceftriaxona hasta el 05/12. Sin Hcs de control.

Se realiza control ecográfico abdominal (28/11) que informa aerobilia bilateral mayor a derecha. Hipertensión portal. Esplenomegalia.

Además se realiza los sgtes estudios:

02/12/24 ECO CARDIO: Dilatación de las cuatro cavidades cardíacas con aspecto hiperdinámico y buena función sistólica biventricular (FEVI 60%). Prueba de contraste salino agitado sugerente de ligero shunt extracardiaco. Estimación de presión

Fecha Epicrisis : 19/12/2024 17:57

Fecha Última Actualización: 19-12-2024 17:57:09

Página 2 de 3

sistólica de arteria pulmonar en rango normal.

02/12/24 TAC TAP: Signos de daño hepático crónico con moderada esplenomegalia, moderada ascitis y formación de circulación colateral porto sistémica como marcadores de hipertensión portal. Examen sin evidencias de dilatación de la vía biliar intrahepática. Drenaje biliar externo - interno con extremo distal a nivel del colédoco entero anastomosis.

En este contexto, se programa biopsia hepática percutánea por radiología Intervencional, que se realiza el 13/12, previa transfusión de 3 U PFC + 2 U GR. Se biopsia lóbulo hepático derecho, se toman 2 muestras de 23 mm.

Posterior a procedimiento, pte evoluciona con compromiso de conciencia, sospecha de encefalopatía hepática, con compromiso HDN e hipotensión sostenida, siendo trasladada a UTI Qx.

Evoluciona en malas condiciones generales, con función hepática en deterioro, coagulopatía secundaria, encefalopatía hepática y compromiso HDM con hipotensión sostenida (PAM 55)

Evaluada el 15/12, más comprometida de conciencia, en sopor medio a profundo, desorientada, con requerimiento de CNAF por mala mecánica respiratoria, siendo presentada a UPC por deterioro clínico franco, y de momento con chance de manejo activo pues sin contraindicación a trasplante hepático en caso de resolverse intercurrentia.

En contexto de IRAg x compromiso de conciencia y compromiso HDM, se realiza intubación orotraqueal por anestesia, Cormack I, sin incidentes. Se conecta a VMI. En espera de traslado a UCI.

Concomitantemente se describe sangrado activo por cavidad oral, con contenido hemático por SNG. Ante sospecha de hemorragia digestiva variceal se inicia terlipresina (recibe dos dosis de 1 mg), IBP endovenoso y ceftriaxona 2 gr. En contexto de sangrado y coagulopatía con INR alterado, se transfunde con 4 PFC y recibe 1 gr de Ac tranexámico.

EDA (realizada previo al traslado): pangastropatía hemorrágica; duodenitis; Úlcera duodenal 6 mm; inyectoterapia. Varices esofágicas sin estigmas de sangrado.

Pte ingresa a UCI en la madrugada del , inestable HDM, con NAD 0.35, patrón vasoplejico, en ritmo sinusal normocárdica al monitor. CRT enlentecido. Sangrado activo de cavidad oral.

Su evolución en esta unidad fue desfavorable y se resume en los siguientes sistemas

En lo hemodinámico paciente evolucionó con shock séptico foco respiratorio. Se agregó disfunción multiorgánica con falla hematológica, renal, vascular, respiratoria, hepática. El 19/12/24 con shock profundo refractario NAD 1ug.kg.h. Vasopresina 0.06ui/min. Con ecoscopia con VTI y TAPSE en rango. hiperdinámico. Sin beneficiarse de un tercer vasoactivo. En ese contexto se avisa a familia de situación clínica fuera de pronóstico y recuperabilidad.

19/12/24 se constata fallecimiento 17:20 hrs

En lo respiratorio con neumonía. Disfunción respiratoria progresiva. Se da soporte hasta su fallecimiento.

En lo infeccioso ingresó con sospecha de intercurrentia infecciosa abdominal asociado a procedimientos descritos vs antecedente de colangitis a repetición, por lo que se inicia empíricamente antibioterapia de amplio espectro (Vancomicina + Meropenem por riesgo proconvulsivo) y fluconazol para cobertura antifúngica. Se cambia por anidulafungina. Hemocultivos negativos, CAET para Pseudomonas aeruginosa MS y Klebsiella BLEE S a Meropenem. PanCT con foco de condensación basal izquierdo. Se mantuvo con terapias.

En lo Digestivo con HDA en contexto de gastropatía difusa no susceptible a tratamiento endoscópico, y también con coagulopatía severa. Se mantuvo con IBP en dosis altas, pese a lo que persiste con sangrado intermitentemente.

En lo neurológico con encefalopatía hepática grado III-IV. Presenta durante estadía movimientos estereotipados en pies, pudiendo corresponder a eventos comiciales o a mioclonias. Se inicia empíricamente anticonvulsivantes. EEG no se concluyó.

En lo renal hidroelectrolítico con falla orgánica múltiples. En contexto de eventual candidatura a trasplante hepático discutido caso con nefrología, decidiendo dar chance con hemodiafiltración continua + dializado con albúmina para depuración de bilirrubina.

En lo hematológico con coagulopatía multifactorial. politransfundida manteniendo

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

Falla multiorgánica.

Shock séptico refractario.

NAAS x broncoaspiración vs sepsis foco abdominal.

Shock hemorrágico resuelto

- HDA no variceal: Úlcera duodenal/inyectoterapia

Falla renal con req de TRR

Falla hematológica

Coagulopatía multifactorial

Politransfundida.

Compromiso de conciencia en estudio:

Fecha Epicrisis : 19/12/2024 17:57

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 19-12-2024 17:57:09

Página 3 de 3

- Encefalopatía hepática reagudizada: HDA, sepsis probable, falta deposiciones, progresión disfunción hepática
ACLF
Sospecha de síndrome convulsivo.
Insuficiencia respiratoria aguda 2° compromiso de conciencia
TOT para protección vía aérea 15/12
POP Drenaje biliar interno-externo (26/11/24)

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico - Falla multiorgánica.
Shock séptico refractario.
NAAS x broncoaspiración vs sepsis foco abdominal.
Shock hemorrágico resuelto
- HDA no variceal: Úlcera duodenal/inyectoterapia
Falla renal con req de TRR
Falla hematológica
Coagulopatía multifactorial
Politransfundida.
Compromiso de conciencia en estudio:
- Encefalopatía hepática reagudizada: HDA, sepsis probable, falta deposiciones, progresión disfunción hepática
ACLF
Sospecha de síndrome convulsivo.
Insuficiencia respiratoria aguda 2° compromiso de conciencia
TOT para protección vía aérea 15/12
POP Drenaje biliar interno-externo (26/11/24)

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallecida

Plan Post Alta

-

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Gonzalo Carvajal Navarrete
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 19/12/2024 17:57

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:43

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar